INFORME CLÍNICO PARA CONSULTA DE ALERGOLOGÍA

HISTORIAL SISTEMATIZADO DE MEDICAMENTOS Y REACCIONES CUTÁNEAS (PICORES / SARPULLIDOS)

Ubicación: IA TEMAS VARIOS / SEGUMINENTO MEDICINAS JAVI | Paciente: Javi (67 años) | Noviembre 2026

OBJETIVO DE LA INTERCONSULTA ALERGOLÓGICA:

Sistematización cronológica de todas las reacciones adversas dérmicas (prurito, sarpullidos, granos) tras la toma de fármacos a lo largo de la vida. Se detallan latencia, intensidad, si cedió espontáneamente o exigió retirada, y control negativo de fármacos tolerados.

1. Tabla Maestra Cronológica de Fármacos y Picores (Parte 1: 1997 a 2006)

Fecha	Medicamento	Familia / Grupo	Motivo	Características del Picor	¿Se Pasó / Quitó?	Medidas
1997	**CLAMOXIL (Amoxicilina 500)**	Betalactámico (Penicilina)	Amigdalitis aguda	Sarpullido eritematoso difuso en el pecho.	Se quitó tras suspender. En 2017 tomó Amoxicilina 750 y volvieron algunos picores.	Suspensión. Sospecha firme de alergia.
01/02/1999	**VELMONIT 500 (Ciprofloxacino)**	Fluorquinolona	Amigdalitis aguda	Sarpullido pruriginoso en el pecho + nerviosismo agudo.	Se quitó tras la retirada del fármaco a los 3 días.	Suspendido a los 3 días de inicio.
07/05/1999	**BRONGENIT (Cotrimoxazol)**	Sulfamida (Sulfametoxazol)	Prostatitis	Picores cutáneos a la 3a pastilla. Agitación a la 5a y 6a.	Se resolvieron los picores tras suspender el fármaco.	Suspendido a la 6a pastilla por prurito.
11/05/1999	**VIBRACINA (Doxiciclina)**	Tetraciclina	Prostatitis	Tomado 7 días completos. El último día sarpullido en costado.	El sarpullido remitió en los días posteriores a 7 días.	Fin de pauta; posterior disbiosis tratada.
08/10/2001	**SURNOX (Ofloxacino)**	Fluorquinolona	Prostatitis	A la 2a pastilla picores notables en espalda + agitación.	Al 6o día se pasaron por completo los picores (18 comp).	Apoyo de Orfidal; el prurito cedió al día 6.
01/12/2003 01/04/2004	**BENERVA (Vitamina B1)**	Vitamina (Tiamina)	Suplemento vitamínico	2003: Prurito en 1a pastilla; granos frente/pecho. 2004: Picadura roja dedo pie.	Se quitó por completo a los 5 días aproximadamente.	Retirada de la B1; remisión espontánea.
01/06/2004	**MICOSPORT (Bifonazol)**	Antifúngico imidazólico	Micosis cutánea (hongos)	Eficaz contra hongos. Al 7o día brotaron granos en frente y pecho.	Erupción papulosa tardía que remitió tras suspender.	Suspensión al 7o día tras curar micosis.
01/08/2004	**ALPRAZOLAM 0,25 mg**	Benzodiazepina	Ansiedad / insomnio	Picores sin granos visibles, como pinchitos en brazos y cabeza.	Duró 5 días y se pasó por completo solo.	Autolimitado; remisión en 5 días.
26/12/2006	**KLACID UNIDIA (Claritromicina 500)**	Macrólido (14 átomos)	Infección respiratoria	Picores crecientes e intensos en piernas, palpitaciones.	Desapareció tras la interrupción inmediata del fármaco.	Suspendido a la 3a pastilla de urgencia.

1. Tabla Maestra Cronológica (Parte 2: 2015 a 2026)

Continuación del registro histórico vital y fila de control de contraste (tolerancia sin picores):

Fecha	Medicamento	Familia / Grupo	Motivo	Características del Picor	¿Se Pasó / Quitó?	Medidas
12/03/2015	**AZITROMICINA 500 mg**	Macrólido Azálido (15 átomos)	Recaída gripe / faringitis	Con la 1a pastilla picores en ambos brazos.	Se pasaron solos y desaparecieron a las 3 horas.	Tolerancia posterior (en 2017 tolerado OK).
20/04/2017	**AMOXICILINA 750 mg**	Betalactámico (Penicilina)	Extracción muela juicio	Tomó 11 pastillas; algunos picores y palpitaciones 4a tarde.	Picores leves que cedieron al concluir el ciclo.	Completó ciclo; confirma reactividad.
27/10/2022 19/12/2025	**PERMIXON 160 (Serenoa repens)**	Fitoterapia urológica	PSA alto / prostatitis	En 2022: picores aleatorios al 5o día. En 2025: en extremidades.	En 2022 se quitaron al dejarlo (volvieron al reanudar).	En 2022 retirada; en 2025 continuación.
17/03/2023	**PROCTOIAL RECTAL**	Ácido hialurónico rectal	Fisura anal	Aplicación cada 12 h. Escozor y picor perianal en 2a dosis.	Picor circunscrito a la zona de contacto mucoso.	Uso continuado con ajuste posológico.
08/02/2024	**NASONEX (Mometasona)**	Corticoide nasal tópico spray	Catarro vías altas	Pequeños picores aleatorios con la 1a inhalación.	Se pasó al poco rato; tomas siguientes de 14 días OK.	Autolimitado en min; tolerancia completa.
Mayo 2024	**INFILTRACIÓN CORTICOIDES**	Corticoide local (Infiltración parenteral)	Dolor cresta ilíaca izq.	Picores corporales durante 5 días tras infiltración cresta ilíaca izq.	Duró 5 días y remitió por completo espontáneamente.	Autolimitado en 5 días; aclaramiento del depósito.
15/01/2025	**LEVOFLOXACINO 500 mg (7 días)**	Fluorquinolona	Infección resp. La Moraleja	Picores en brazos/axilas (días 1-3) y piernas (días 4-6).	El último día ya no tuvo ningún picor.	Crema de Urea; no precisó Aerius.
14/08/2026	**EZETIMIBA 10 mg**	Hipolipemiante (Inhib. NPC1L1)	Control colesterol c-LDL	Prurito cutáneo generalizado migratorio durante 15 días.	No se quitó solo; requirió medicación diaria continua.	Aerius diario y Urea. Suspendido.
08/10/2026	**PITAVASTATINA (Livazo)**	Estatina hipolipemiante	Control colesterol c-LDL	Picores corporales difusos a la 3a semana de tratamiento.	Se quitó al suspender el tratamiento farmacológico.	Aerius 1 día y retirada; vuelta a Atorvastatina.
2022 - 2026 [CONTROL]	**ATORVASTATINA 20 mg (Tolerado)**	**Estatina hipolipemiante**	**Control colesterol c-LDL**	**CERO PICORES. Tolerancia cutánea excelente permanente.**	**Tolerancia continuada permanente (LDL en 64).**	**Fármaco tolerado. Control negativo.**

NOTA CLÍNICA SOBRE LA FILA DE CONTROL [ATORVASTATINA 20 mg]:

Demuestra que el prurito no es un efecto de clase generalizado, sino que depende de moléculas y excipientes específicos.

2. Análisis de Patrones por Familias Farmacológicas

El análisis sistemático del registro vital permite extraer patrones clave para orientar las pruebas de alergia:

Familia Farmacológica	Fármacos Evaluados y Reacciones Cutáneas	Hipótesis Diagnóstica / Mecanismo Sugerido
Betalactámicos (Aminopenicilinas)	- Clamoxil (1997): Sarpullido en pecho (suspendido). - Amoxicilina 750 (2017): Picores leves y palpitaciones. - RAST Amoxicilina (26/11/2002): <0,35 limítrofe.	Hipersensibilidad no mediada por IgE inmediata o reactividad retardada a aminopenicilinas. Exige verificar seguridad de Cefalosporinas de 3a generación.
Fluorquinolonas (Cipro, Oflo, Levo)	- Ciprofloxacino (1999): Sarpullido en pecho (retirado 3d). - Ofloxacino (2001): Picores espalda que cedieron al 6o día. - Levofloxacino (2025): Picores brazos/piernas que cedieron.	Degranulación mastocitaria directa no inmunológica (vía receptor MRGPRX2). Explica por qué el prurito puede atenuarse durante la pauta continuada.
Corticoides (Tópico nasal vs Infiltración local)	- Nasonex spray (Feb 2024): Picor transitorio en minutos. - Infiltración cresta ilíaca izq. (Mayo 2024): Picores corporales durante 5 días que remitieron espontáneamente al aclararse.	Diferencia sustancial entre absorción tópica mucosa (reacción fugaz) y liberación parenteral de depósito (prurito sistémico transitorio autolimitado a 5 días).
Macrólidos (Claritro vs Azitro)	- Claritromicina (2006): Picores intensos y palpitaciones (3d). - Azitromicina (2015, 2017): Picores fugaces de 3 horas; excelente tolerancia en tratamientos posteriores.	Intolerancia al anillo de 14 átomos (Claritromicina) con tolerancia conservada al anillo azálido de 15 átomos (Azitromicina de elección).
Hipolipemiantes (Ezetimiba, Pitava vs Atorvastatina)	- Ezetimiba (2026): Prurito diario 15 días (Aerius + Urea). - Pitavastatina (2026): Picores a la 3a semana (Aerius). - Atorvastatina 20 mg (2022-2026): CERO PICORES.	Prurito dependiente de molécula específica y no efecto de clase. Atorvastatina es el fármaco de elección biológicamente neutro.

3. Puntos Concretos de Consulta y Decisión con el Alergólogo

Punto de Decisión Clínica	Pregunta Concreta para la Consulta	Impacto en la Salud del Paciente
1. Pruebas Cutáneas para Betalactámicos	¿Procede realizar pruebas cutáneas (Prick / Intradérmica) para penicilina y amoxicilina para confirmar si existe alergia IgE o exclusión formal?	Confirmar si las cefalosporinas de 3a generación (Ceftriaxona / Cefixima) son seguras ante infecciones de orina o respiratorias.
2. Mecanismo de Quinolonas (MRGPRX2)	Dado que con Ofloxacino y Levofloxacino el prurito remitió progresivamente al 6o-7o día, ¿se confirma el mecanismo pseudoalérgico no IgE?	Evita vetar toda la familia de quinolonas si se requiere un rescate urológico específico bajo premedicación.
3. Corticoides Parenterales e Infiltraciones	Valorar la reactividad frente a corticoides depot tras los picores de 5 días por la infiltración en cresta ilíaca izq. de Mayo 2024.	Garantizar la seguridad de futuras infiltraciones osteoarticulares (ej. rodilla o columna) sin brotes de prurito.
4. Panel Seguro y Control Lipídico	Fijar panel antibiótico autorizado y constatar que el prurito con Ezetimiba no contraindica Atorvastatina ni Ácido Bempedoico.	Tranquilidad absoluta ante prescripciones urgentes y control de c-LDL sin riesgo dérmico ni muscular.